

無・気道刺激による気道過敏性亢進の有無を確認する。肺機能検査が難しい場合には、ピークフローメーターを用いた日内変動（朝と夜の数値差を朝と夜の平均で除して求める）が20%以上であることが変動性気流制限の証明となる。これらの所見のうち、ひとつでも陽性所見があれば、喘息と診断する。また、これらの所見が陽性にならなかった場合でも、喘息病態に

表 2 喘息診断の目安

1. 発作性の呼吸困難、喘鳴、胸苦しさ、咳の反復
2. 可逆性の気流制限
3. 気道過敏性の亢進
4. 気道炎症の存在
5. アトピー素因
6. 他疾患の除外

・上記 1, 2, 3, 6 は診断に重要である。
・4 が 2 型炎症（好酸球性）の場合は診断的価値が高い。
・5 の存在は喘息の診断を支持する。

[日本アレルギー学会喘息予防・管理ガイドライン 2024WG（監修）：喘息予防・管理ガイドライン 2024，協和企画，p5，2024 より許諾を得て転載]

深くかかわるアレルギー要素や慢性気道炎症を評価することで総合的に判断していく必要がある。実際には、環境アレルゲンに対する特異的 IgE の存在・アレルギー疾患の併存の有無・血中あるいは喀痰中好酸球数増多の有無・呼気一酸化窒素（FeNO）高値の有無を評価する。しかし、喘息による気道閉塞が重篤であったり、検査そのものが施行できる体制にないなど、これらの検査が行えない場合もある。そのような場合には、客観的な指標で判断ができていないことに留意しつつ、喘息として治療を開始し、その治療反応性で判断することも可能である。咳嗽・呼吸困難を引き起こす疾患は多数存在するため、喘息の診断をつける際には、喘息と診断し得る検査だけでなく、他疾患を除外するための検査も同時に行うことが必要不可欠である。（表 3）¹⁾

b 診断に有用な症状と検査

i) 特徴的な症状

喘息で典型的に認められる症状としては、喘鳴・息切れ・咳嗽・胸苦しさの複数の組み合わせが変動性を

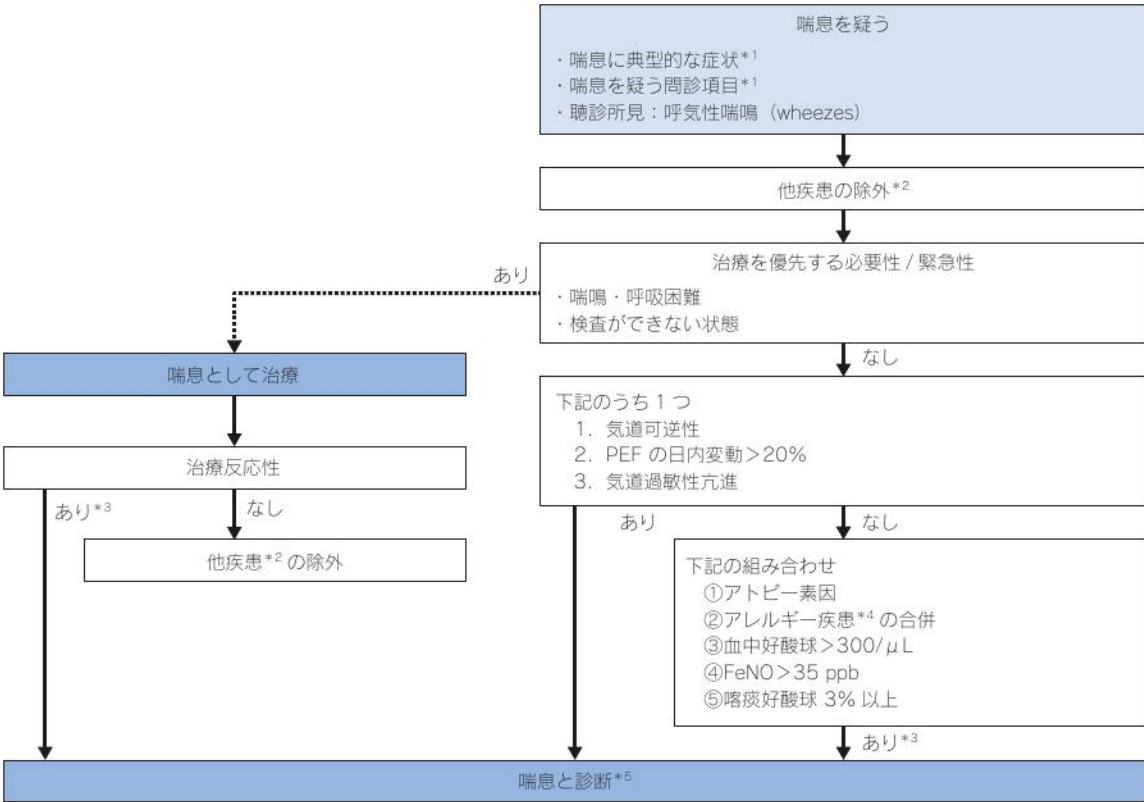


図 1 喘息診断のためのアルゴリズム

(備考) *1 ガイドラインを参照。
*2 他疾患の除外はガイドラインを参照。合併症の評価も行う。
*3 経過中に気道可逆性、PEF の日内変動 > 20%、気道過敏性亢進のいずれかを確認すること。
*4 アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎、副鼻腔炎の合併。
*5 治療への反応性を評価し、乏しい場合は診断を見直すこと。

[日本アレルギー学会喘息予防・管理ガイドライン 2024WG（監修）：喘息予防・管理ガイドライン 2024，協和企画，p6，2024 より許諾を得て転載]